del suo sviluppo emozionale. È questa parte del lavoro che libera il paziente dalla sua dipendenza dall'analista.

In questo modo il transfert negativo dell'analisi « nevrotica » viene sostituito da una collera oggettiva contro le carenze dell'analista. Si tratta di un'altra differenza importante tra i fenomeni di transfert di questi due generi di lavoro.

Non dobbiamo cercare una colpevolezza dei nostri successi d'adattamento poiché non sono sentiti come tali ad un livello profondo. Sebbene non possiamo fare a meno della teoria elaborata nel corso delle nostre discussioni, questo lavoro scoprirà inevitabilmente le nostre deficienze se la nostra comprensione del bisogno del paziente ci deriverà dall'intelletto piuttosto che dallo psiche-soma.

Nel mio lavoro clinico ho verificato, almeno per quel che mi riguarda, che un tipo di analisi non esclude l'altra. Mi capita di passare dall'una all'altra e di ritornare indietro, secondo l'andamento del processo inconscio del paziente. Quando il lavoro speciale di cui ho parlato è completato si passa naturalmente ad un lavoro analitico di tipo comune, all'analisi cioè della posizione depressiva e delle difese nevrotiche di un paziente dotato di un Io intatto e capace di vivere le pulsioni dell'Es e di assumersene le conseguenze. Ciò che resta ora da fare è studiare nei particolari i criteri che permettono all'analista di sapere *a che punto passare da un tipo all'altro di lavoro* e di capire quando sta sorgendo un bisogno del tipo che, come ho detto, deve essere soddisfatto (almeno in forma simbolica) da un adattamento attivo. L'analista non cesserà di tenere a mente il concetto d'identificazione primaria.

CAPITOLO XXIV

La preoccupazione materna primaria

Questo saggio è stato sollecitato dalla discussione pubblicata nello *Psychoanalytic Study of the Child,* vol. IX, sotto il titolo « Problemi di nevrosi infantile ». I vari contributi di Anna Freud in questa discussione sono importanti perché espongono quella che è l'attuale teoria psicoanalitica riguardo ai primissimi stadi dello sviluppo infantile e alla formazione della personalità.

Desidero sviluppare il tema del rapporto più primitivo madre-bambino, un tema che è della massima importanza all'inizio e che solo gradualmente passa in seconda linea rispetto a quello del bambino che sta diventando un essere indipendente.

Come prima cosa mi sembra necessario sostenere Anna Freud quando parla delle « Concezioni errate correnti ». « Delusioni e frustrazioni sono inevitabili nella relazione madre-bambino... Rendere responsabili della nevrosi infantile le carenze materne nella fase orale è solo una facile ed ingannevole generalizzazione. L'analisi deve cercare più lontano e più in profondità la causa determinante della nevrosi ». Con queste parole Anna Freud esprime una concezione generalmente sostenuta dagli psicoanalisti.

Ciò nonostante può rivelarsi più utile prendere in considerazione la posizione della madre. Vi può essere un ambiente che non è sufficientemente buono e che altera lo sviluppo del bambino così come vi può essere un ambiente sufficientemente buono che permette al bambino di sperimentare le soddisfazioni innate, le angosce ed i conflitti propri di ogni stadio.

Anna Freud ci ricorda che la condizione pregenitale può essere rappresentata da due persone unite per realizzare ciò che, per brevità, si potrebbe chiamare « equilibrio omeostatico » (Mahler, 1954). È lo stesso concetto che si definisce con il termine « relazione simbiotica ». Si afferma

spesso che la madre di un bambino piccolo è biologicamente condizionata al suo lavoro orientato in modo particolare a soddisfare i bisogni del bambino. In linguaggio corrente si dirà che vi è un'identificazione conscia, ma anche profondamente inconscia, della madre con il suo bambino.

Penso che bisognerebbe riunire questi vari concetti e studiare la madre indipendentemente dall'aspetto puramente biologico. Il termine simbiosi non ci porta più lontano di quanto ci porti il confronto della relazione madre-bambino con altri esempi della vita animale e vegetale d'interdipendenza fisica. L'espressione equilibrio omeostatico trascura, ancora una volta, alcuni degli elementi più impercettibili che si evidenziano quando consideriamo questa relazione con tutta l'attenzione che merita.

Ciò che ci interessa sono le notevolissime differenze *psicologiche* esistenti tra l'identificazione della madre con il suo bambino piccolo e la dipendenza del bambino dalla madre. Questa dipendenza non implica nessuna identificazione, poiché l'identificazione è uno stato di cose molto complesso che non si può applicare alle prime fasi dell'infanzia.

Anna Freud ci dimostra che abbiamo di gran lunga superato quella fase meno evoluta della teoria psicoanalitica in cui si parla come se la vita del bambino iniziasse con l'esperienza istintuale orale. Oggi siamo impegnati nello studio delle fasi precoci dello sviluppo e del Sé primitivo che, se lo sviluppo è abbastanza avanzato, può essere rafforzato invece che danneggiato dalle esperienze dell'Es.

Anna Freud dice, sviluppando il tema del termine « anaclitico » di Freud: « Il rapporto con la madre, anche se è il primo rapporto con un altro essere umano, non è tuttavia il primo rapporto del bambino con l'ambiente. Ciò che lo precede è una fase più precoce in cui non è tanto il mondo oggettuale a giocare il ruolo decisivo quanto i bisogni del corpo e la loro soddisfazione o frustrazione ».

Tra parentesi, mi sembra che l'introduzione della parola « bisogno » al posto della parola « desiderio » sia molto importante per la formulazione della nostra teoria, ma avrei preferito che Anna Freud non avesse usato qui le parole « soddisfazione » e « frustrazione »; si può rispondere o no ad un bisogno, e l'effetto non è lo stesso che quello della soddisfazione o della frustrazione della pulsione dell'Es.

Posso citare Greenacre (1954) quando parlo del tipo di piacere ritmico « cullante ». Troviamo qui un esempio di bisogno a cui si risponde o no, ma sarebbe errato dire che il bambino che non è cullato prova una frustrazione. Non vi è certamente collera quanto invece una specie di alterazione dello sviluppo primitivo.

Comunque sia, mi sembra che manchi uno studio più approfondito della funzione materna *nelle fasi più precoci* per cui spero di raccogliere e riunire i vari suggerimenti ed avanzare una proposta di discussione.

La preoccupazione materna

La mia tesi è che, nella primissima fase, osserviamo nella madre uno stato molto particolare, una condizione psicologica che merita il nome di *preoccupazione materna primaria*. Mi sembra che né nella nostra letteratura, né forse altrove, non si è ancora prestata sufficiente attenzione ad uno stato psichiatrico molto particolare della madre, di cui vorrei dire che:

Si sviluppa a poco a poco per raggiungere un grado di elevata sensibilità durante la gravidanza, e specialmente verso la fine.

Dura ancora poche settimane dopo la nascita del bambino.

Una volta superato, non è facile che sia ricordato dalla madre. Direi di più, e cioè che la madre tende a rimuovere il ricordo che ne ha.

Questo stato organizzato (che sarebbe una malattia se non vi fosse il fatto della gravidanza) potrebbe essere paragonato ad uno stato di ritiro, ad uno stato di dissociazione, ad una fuga o perfino ad un disturbo più profondo, quale un episodio schizoide in cui uno degli aspetti della personalità prende temporaneamente il sopravvento. Vorrei trovare un nome adatto a questo stato e proporlo come qualcosa da prendere in considerazione tutte le volte che si parla della primissima fase della vita infantile. Non credo che si possa comprendere la funzione della madre all'inizio della vita del bambino senza ammettere che essa deve essere capace di raggiungere questo stato di elevata sensibilità, quasi una malattia, e di guarirne. (Uso il termine « malattia » perché una donna deve essere sana per poter sia raggiungere questo stato sia uscirne quando il bambino la lascia libera. Se il bambino morisse lo stato della madre si rivelerebbe immediatamente patologico. È il pericolo che la madre corre).

Tutto ciò è contenuto nel termine « devoto » che uso quando parlo di una « comune madre devota » (Winnicott, 1949). Vi sono certamente molte donne che sono buone madri in tanti altri modi e che sono capaci di una vita ricca e piena ma che non sono capaci di questa « malattia normale » che permetterebbe loro di adattarsi con delicatezza e sensibilità ai primi bisogni del bambino. Oppure ne sono capaci con un bambino e non con un altro. Queste donne non sono capaci di preoccuparsi del

loro bambino piccolo escludendo qualsiasi altro interesse, nel modo che è temporaneamente normale. Si può supporre in alcune di esse una « fuga verso la sanità ». Ve ne sono alcune che hanno certamente degli altri interessi molto importanti che non sono pronte ad abbandonare o che sono capaci di lasciare solo dopo aver avuto il loro primo bambino. Quando una donna ha una forte identificazione maschile trova particolarmente difficile svolgere questa parte della sua funzione materna, e l'invidia del pene rimossa lascia poco spazio alla preoccupazione materna primaria.

Ne consegue, in pratica, che queste donne, che hanno messo al mondo un bambino ma hanno fallito nella primissima fase, devono compensare la loro carenza. Attraversano allora un lungo periodo in cui si devono adattare il più possibile ai bisogni del loro bambino che sta crescendo, e non è sicuro che riescano a ripassare il danno provocato nei primi tempi. Invece di godere del buon affetto di una preoccupazione temporanea precoce si trovano coinvolte nella necessità d'una terapia per il loro bambino, di un periodo prolungato cioè di adattamento ai suoi bisogni, o di vizi. Fanno le terapiste invece che le madri.

Lo stesso fenomeno viene menzionato da Kanner (1934), da Loretta Bender (1947) e da altri autori che hanno tentato di descrivere il tipo di madre che può produrre un « bambino autistico » (Creak, 1951; Mahler, 1954).

Si può fare a questo proposito un paragone tra il compito della madre che deve compensare la sua incapacità perduta e quello della società che tenta (qualche volta con successo) di condurre un bambino che ha sofferto di carenze da uno stato antisociale ad una identificazione sociale. Questo lavoro della madre (o della società) si rivela un grosso sforzo perché non viene fatto naturalmente; esso riguarda in realtà un'epoca anteriore, in questo caso l'epoca in cui il bambino incomincia appena ad esistere come individuo.

Se questa tesi dello stato particolare della madre normale e della guarigione da questo stato è plausibile, possiamo allora esaminare più da vicino lo stato corrispondente del bambino.

Il bambino piccolo ha:

una costituzione;
delle tendenze innate di sviluppo (« la sfera dell'Io libera da conflitti »);
una mobilità ed una sensibilità;
degli istinti, impliciti nella tendenza allo sviluppo e legati a delle zone la cui predominanza è variabile.

La madre che realizza lo stato che ho chiamato « preoccupazione materna primaria » offre al bambino delle condizioni che permetteranno alla sua costituzione d'incominciare ad evidenziarsi, alle sue tendenze di sviluppo d'incominciare a manifestarsi ed al bambino stesso di sperimentare il movimento spontaneo e di diventare padrone delle sensazioni che corrispondono a questa fase della sua vita. Non parlerò qui della vita istintuale perché ciò di cui sto discutendo precede il costituirsi dei modelli istintuali.

Ho cercato di descrivere tutto ciò nel mio linguaggio dicendo che, se la madre si adatta sufficientemente bene al bisogno, la continuità di vita del bambino verrà disturbata molto poco dalle reazioni alle pressioni ambientali. (Sono naturalmente le *reazioni* alle pressioni che contano, non le pressioni stesse). Le carenze materne provocano delle fasi di reazione, e queste interrompono la « continuità dell'essere » del bambino. Un eccesso di reazioni non genera la frustrazione ma una *minaccia di annichilimento*. Questa è per me un'angoscia primitiva molto reale, che precede di gran lunga qualunque angoscia che includa la parola morte nella sua descrizione.

In altre parole, la strutturazione dell'Io si basa su una « continuità dell'essere » sufficiente, non interrotta dalle reazioni all'urto dell'ambiente. Affinché questa continuità sia sufficiente all'inizio è indispensabile che la madre si trovi in questo stato che (secondo me) è uno stato molto reale quando la madre sana è verso la fine della sua gravidanza, e nel corso delle prime settimane dopo la nascita del bambino.

Solo una madre sensibile nel modo che ho descritto può mettersi al posto del suo bambino e rispondere ai bisogni di quest'ultimo. Questi sono all'inizio bisogni del corpo che si trasformano gradualmente in bisogni dell'Io, man mano che una psicologia nasce dall'elaborazione immaginativa dell'esperienza fisica.

Incomincia ad esistere un sistema di relazione tra l'Io della madre e quello del bambino dal quale la madre guarirà e che permetterà al bambino di elaborare l'idea della madre come persona. Da questo punto di vista il riconoscimento della madre come persona avviene in un modo positivo, normalmente, e non proviene da un'esperienza della madre vissuta come simbolo della frustrazione. L'incapacità della madre di adattarsi nelle fasi più primitive non produce null'altro che l'annichilimento del Sé del bambino.

Ciò che la madre fa bene non è per nulla percepito dal bambino di questo stadio. Le sue carenze non sono sentite come carenze materne ma agiscono come una minaccia all'esistenza personale del Sé.

Secondo queste considerazioni, dunque, la strutturazione precoce dell'Io è silenziosa. La prima organizzazione dell'Io proviene dall'esperienza delle minacce di annichilimento che non conducono all'annichilimento e dalle quali, ogni volta, ci si *rimette*. Grazie a quest'esperienza la fiducia nella guarigione incomincia a condurre ad un Io, e ad una capacità dell'Io di affrontare la frustrazione.

Spero che si capirà che questa tesi è un contributo al tema del riconoscimento della madre come una madre frustrante da parte del bambino. Ciò è vero in un secondo tempo ma non in questo stadio così precoce. All'inizio, la madre insufficiente non viene percepita come tale. In verità, per riconoscere la dipendenza assoluta dalla madre e la sua capacità di « preoccupazione materna primaria », o comunque vogliamo chiamarla, è necessaria un'*estrema elaborazione,* e questo è un livello non sempre raggiunto dagli adulti. Generalmente non si riconosce la dipendenza assoluta degli inizi, e ciò contribuisce a generare la paura della DONNA, destino sia degli uomini sia delle donne (Winnicott, 1950, 1957*a*).

Possiamo ora dire perché pensiamo che la madre di un bambino sia la persona adatta ad assistere quel bambino; è lei che può raggiungere questa condizione speciale di « preoccupazione materna primaria » senza essere ammalata. Tuttavia, una madre adottiva, o qualunque altra donna capace di essere ammalata nel senso che abbiamo appena detto, può riuscire ad adattarsi abbastanza bene grazie alla sua capacità d'identificarsi con il bambino.

Secondo questa tesi un ambiente sufficientemente buono nella fase più primitiva offre al bambino la possibilità d'incominciare ad esistere, di avere delle esperienze, di strutturare un Io personale, di dominare gli istinti e di affrontare tutte le difficoltà inerenti alla vita. Tutto ciò è sentito come reale dal bambino, e questi diventa capace di avere un Sé che può eventualmente accettare anche di sacrificare la propria spontaneità, e perfino di morire.

D'altra parte, senza un ambiente iniziale sufficientemente buono, questo Sé che può permettersi di morire non si sviluppa mai. Manca il senso di realtà e, se non vi è troppo caos, il sentimento ultimo è quello d'inutilità. Le difficoltà della vita non possono essere affrontate, e non possono essere nemmeno vissute le sue soddisfazioni. Se non vi è del caos compare un falso Sé che nasconde il vero Sé, che obbedisce alle richieste, che reagisce agli stimoli, che si libera delle esperienze istintuali vivendole, ma che non fa che guadagnar tempo.

Si vedrà, seguendo questa tesi, che i fattori costituzionali si rivelano

più facilmente in condizioni di normalità, in cui l'ambiente si è adattato fin dai primi tempi. Per contro, quando vi è stata carenza in questa prima fase, il bambino viene coinvolto in meccanismi di difesa primitivi (falso Sé, ecc.) collegati con la minaccia di annichilimento, e gli elementi costituzionali tendono ad essere schiacciati (a meno che non vi siano delle manifestazioni fisiche).

Non possiamo sviluppare qui il tema dell'introiezione dei modelli di malattia della madre nel bambino, sebbene quest'argomento sia di grande importanza in considerazione del fattore ambientale negli stadi successivi, dopo la prima fase di dipendenza assoluta.

Nel ricostruire lo sviluppo precoce di un bambino piccolo non vi è assolutamente nessun motivo di parlare di istinti, se non dal punto di vista dello sviluppo dell'Io.

Vi è una linea di separazione tra:

maturità dell'Io – esperienze istintuali rafforzano l'Io
immaturità dell'Io – esperienze istintuali disorganizzano l'Io.

L'Io implica qui una somma di esperienze. Il Sé dell'individuo parte con una somma di esperienze: riposo, mobilità, sensibilità, ritorno dall'attività al riposo, ed il graduale costituirsi di una capacità di attendere la guarigione dagli annichilimenti, quegli annichilimenti che sono il risultato delle reazioni agli urti dell'ambiente. È per questo motivo che l'individuo ha bisogno di iniziare in quell'ambiente specializzato che ho chiamato « preoccupazione materna primaria ».